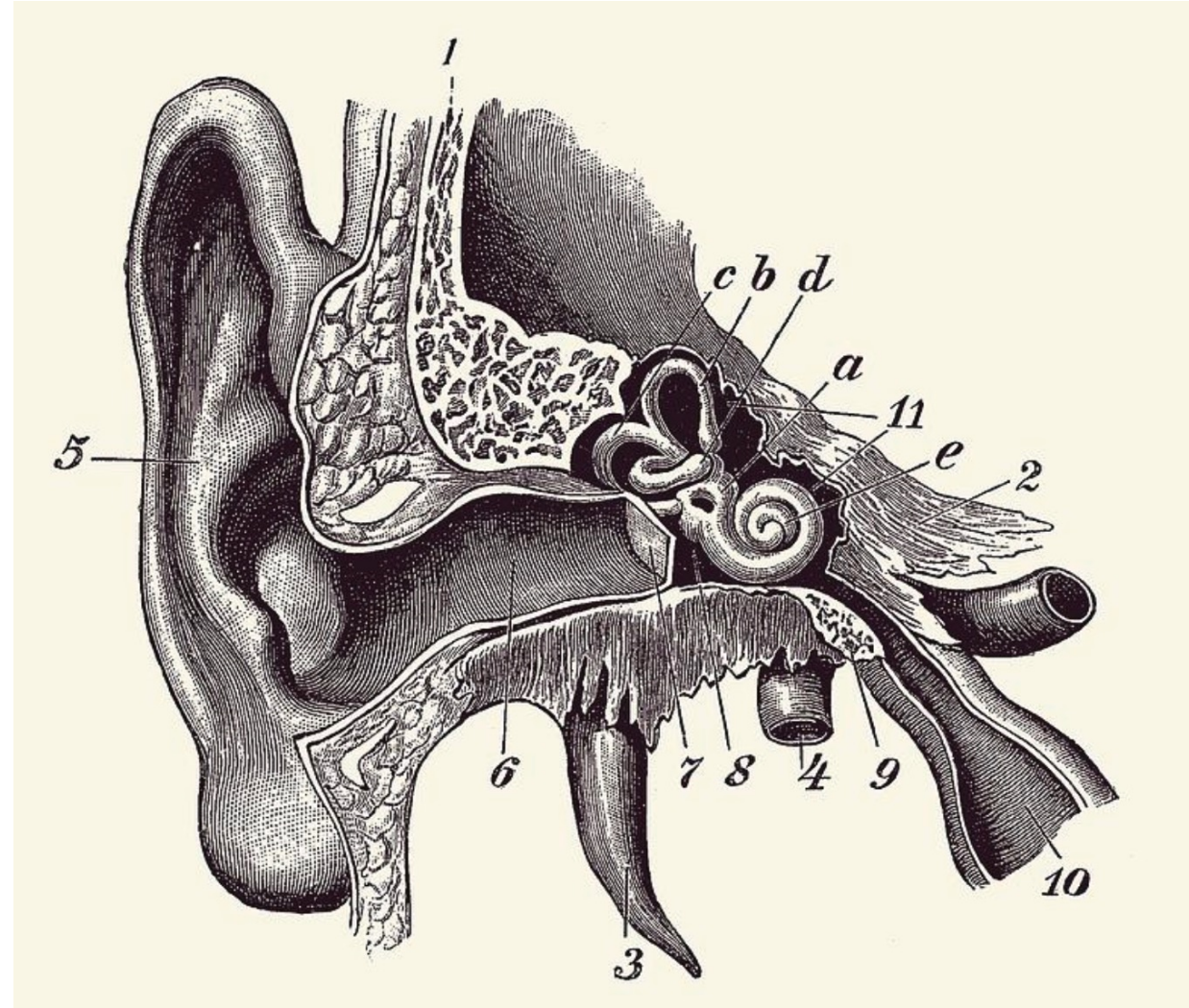
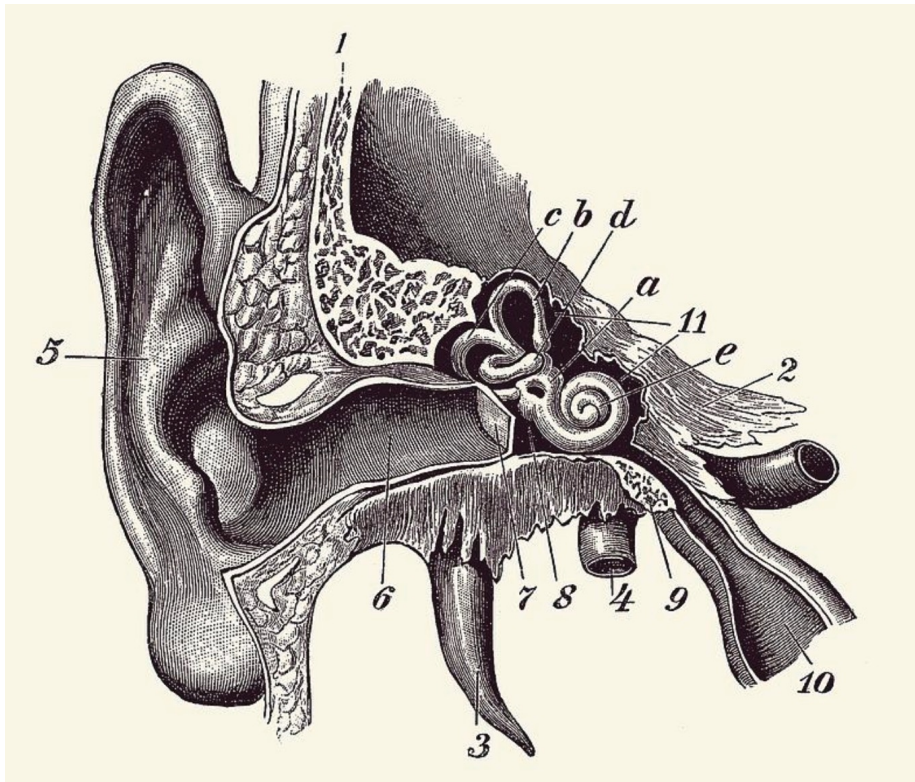


ORL : Pathologies fréquentes



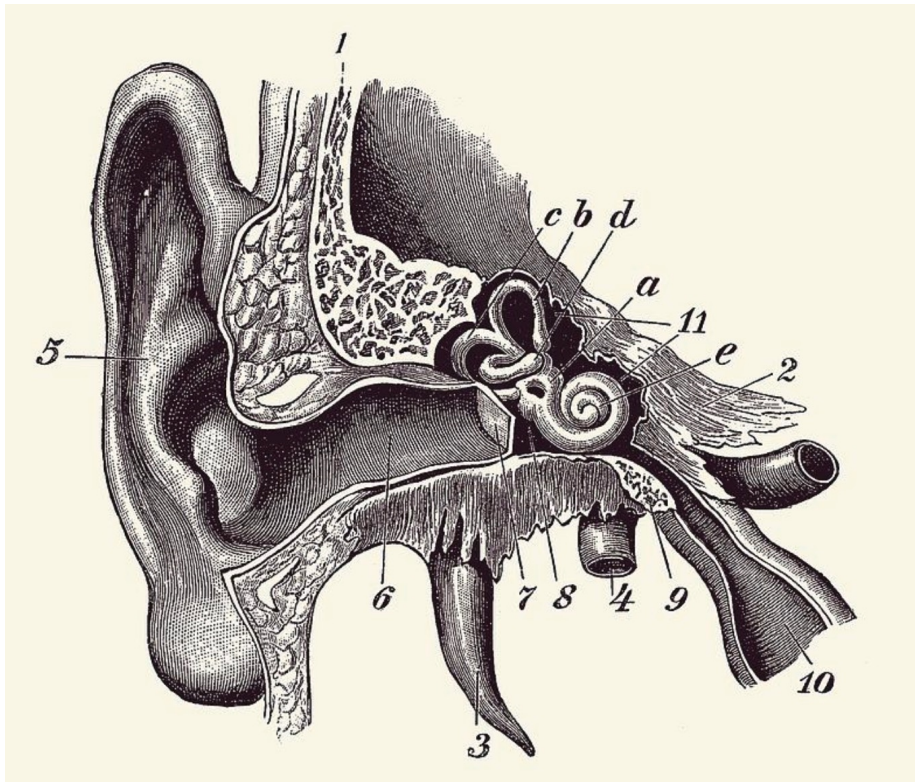


Otite moyenne aiguë :

- **Définition :** Inflammation de l'oreille moyenne, en général causée par une infection bactérienne survenant après une infection virale des voies aériennes supérieures. Incidence maximale entre 6 et 24 mois.
Bactéries fréquentes : *S. pneumoniae*, *H. influenza*, *Moraxella catarrhalis*
Virus sous-jacent fréquent : RSV, influenza, parainfluenza, rhinovirus, adénovirus
- **FR :** Rhinite viral ou allergique, hypertrophie des végétations adénoïdes, polypose nasale.
- **Cliniques :** Ootalgie, fièvre, otorrée (lors de rupture du tympan), surdité de transmission (Rinné négatif)
- **Complications :** **Mastoïdite**, **abcès** (cérébral, post-auriculaire...), **labyrinthite bactérienne**, **paralysie faciale**
- **Diagnostique :** Clinique + visualisation du tympan à l'otoscope (perte cône lumineux, tympan bombé, érythème)
- **Traitement :** Le plus souvent uniquement conservateur avec **AINS/paracétamol** et réévaluation à 48h
Si indiqué*, ajouter une antibiothérapie empirique : **amoxicilline po** seule ou **augmentin po**
*Indication : *Enfant < 6 mois ou adulte*,
Si absence d'amélioration après >72h, lors d'otorrée sans otite externe, porteur d'implant cochléaire
Lors d'infection récurrente ou absence d'amélioration sous AB : **paracentèse**

Otite externe :

- **Définition :** Inflammation de l'oreille externe, le plus souvent sur **infection**, parfois secondaire à une **dermatite atopique** ou un **eczéma de contact** (hyper-sensibilité type IV à des traitement topiques).
Aiguë (< 6 semaines) ou chronique (> 3 mois).
 - Bactéries fréquentes : *P. aeruginosa* (40%), *S. aureus*, *P. mirabilis*, *E. coli*
Virus (plus rarement) : réactivation **VZV**, **influenza**
Champignons (plus rarement): *Aspergillus spp.* >> *Candida spp.*
- **Cliniques :** Ootalgie, douleurs dans la mâchoire, otorrée, prurit, sensibilité du tragus, surdité de transmission.
- **Diagnostique :** Diagnostic clinique basé sur la **présentation clinique et l'otoscopie**.
Cave: Le tympan doit être intact (DD : otite moyenne suppurative chronique)
Possibilité de chercher des comorbidités entraînant un risque accru de complication (diabète, HIV...)
Effectuer des **cultures** des écoulements (en particulier si traitement AB récent ou absence d'amélioration)
Effectuer un **CT** si suspicion d'ostéomyélite de la base du crane sous-jacente (**otite externe maligne**).
- **Traitement :**
Cas non compliqué : Goutte antibiotique (**Ciprofloxacine** ou **Gentamycine**) ± **Corticostéroïde**
Otite externe maligne suspecté, immunosuppression (y-compris DM), cellulite ou extension de l'infection à la peau adjacente : **Ciprofloxacine po**



Otite moyenne chronique :

- **Otite moyenne chronique (OMC) suppuré :**

Fait suite à une otite moyenne aiguë avec perforation du tympan, engendrant un drainage chronique du contenu de l'oreille moyenne vers le CAE (**otorrée**) ainsi qu'une **surdité de transmission**, le tout **sans douleur**.

Les complications comprennent notamment le développement de **cholestéatome** ainsi qu'une surinfection.

Le diagnostic est clinique avec la visualisation d'un defect tympanique à l'otoscopie.

Le traitement est conservateur avec des AB topique (**fluoroquinolone**), des **CS topique** ainsi qu'un nettoyage méticuleux et quotidien. Le tympan régénère spontanément.

- **Choléstéatome :**

Fréquemment la complication d'otite moyenne aiguë à répétition et d'otite moyenne chronique suppuré.

Il s'agit d'une prolifération de l'épithélium tympanique ou du CAE, qui forme une masse qui envahit l'oreille moyenne et parfois la mastoïde. Cet épithélium aberrant conduit à une réaction inflammatoire et détruit progressivement les structures présentes (en particulier la chaîne des osselets).

Les symptômes typiques sont une **otorrée indolore** (fond d'OMC suppurée) et une **surdité de transmission**.

Si la maladie progresse, elle peut éroder l'os et provoquer une **paralysie faciale périphérique** ainsi que des **abcès** et des **thrombose** du sinus sigmoïde. En cas d'atteinte de l'oreille interne, ils peuvent provoquer des **vertiges**.

Le diagnostic requiert une otoscopie, mais surtout une **imagerie en coupe** de la mastoïde et de l'oreille moyenne pour mettre en évidence les choléstéatomes.

Comme les choléstéatomes peuvent progressivement détruire l'oreille, la **chirurgie est toujours indiquée**, avec une excision des choléstéatomes (tympano-mastoïdectomie) et une reconstruction des structures lésées

Otosclérose :

- Excroissance osseuse anormale de l'étrier, qui devient de plus en plus collé à la fenêtre ovale et fini par ne plus conduire les sons correctement, entraînent une **surdité de transmission**. L'atteinte est fréquemment bilatérale.
- Les autres symptômes sont des **acouphènes**, parfois des vertiges et une «**Paracusis willisii** » (le patient entend paradoxalement mieux dans les environnements bruyants que silencieux).
- À l'audiométrie : diminution de la perception des sons à **2'000 Hz** à la **conduction osseuse** (**Carhart's notch**), ainsi qu'une surdité de transmission et une **absence du réflexe stapédien**.
- Le traitement consiste en une **stapédectomie** et son remplacement par une **prothèse**, ou un implant auditif.

Otite externe infectieuse



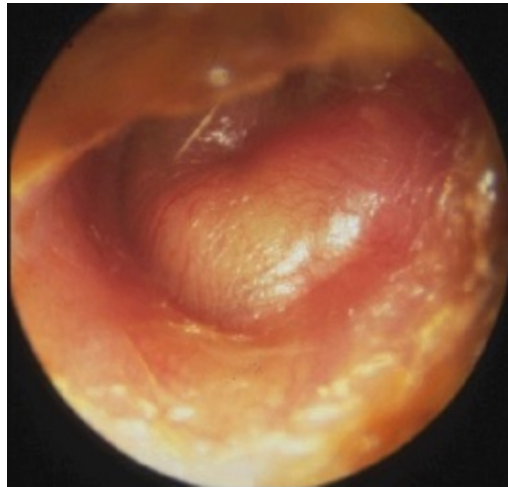
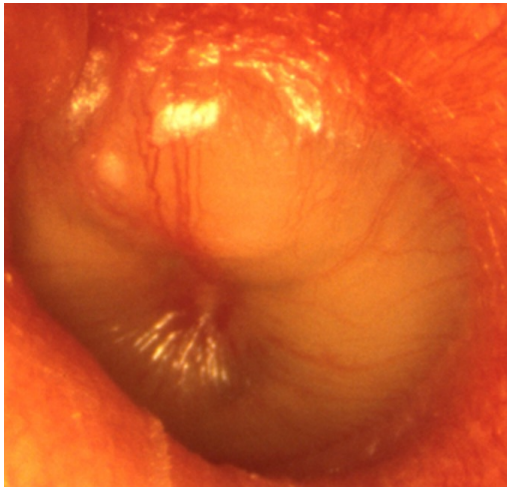
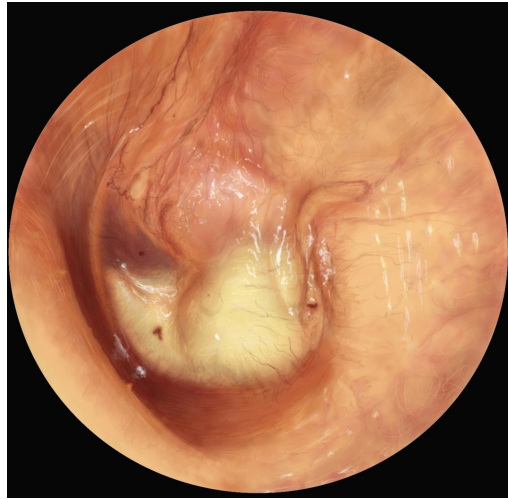
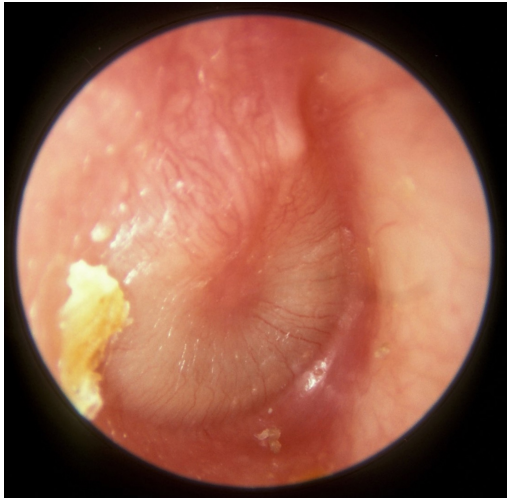
Dermatite atopique



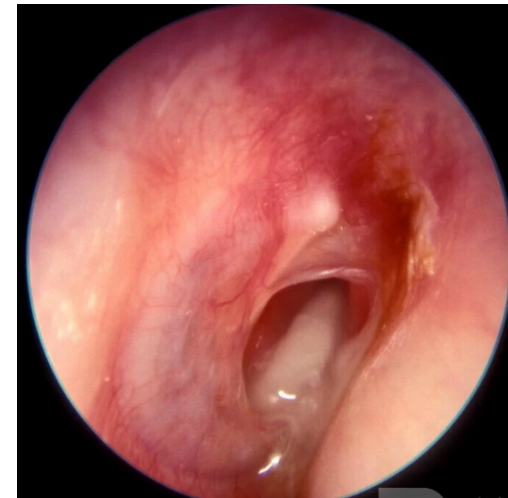
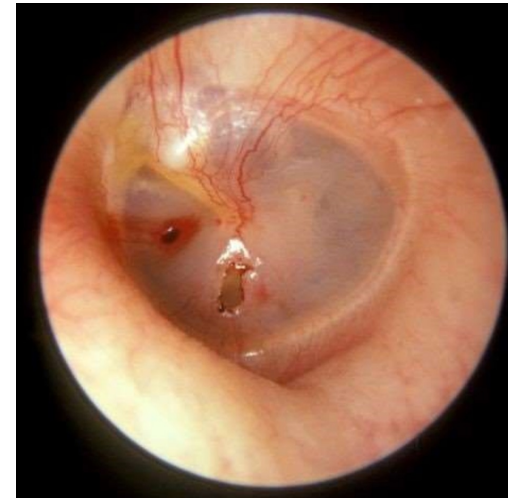
zona auriculaire

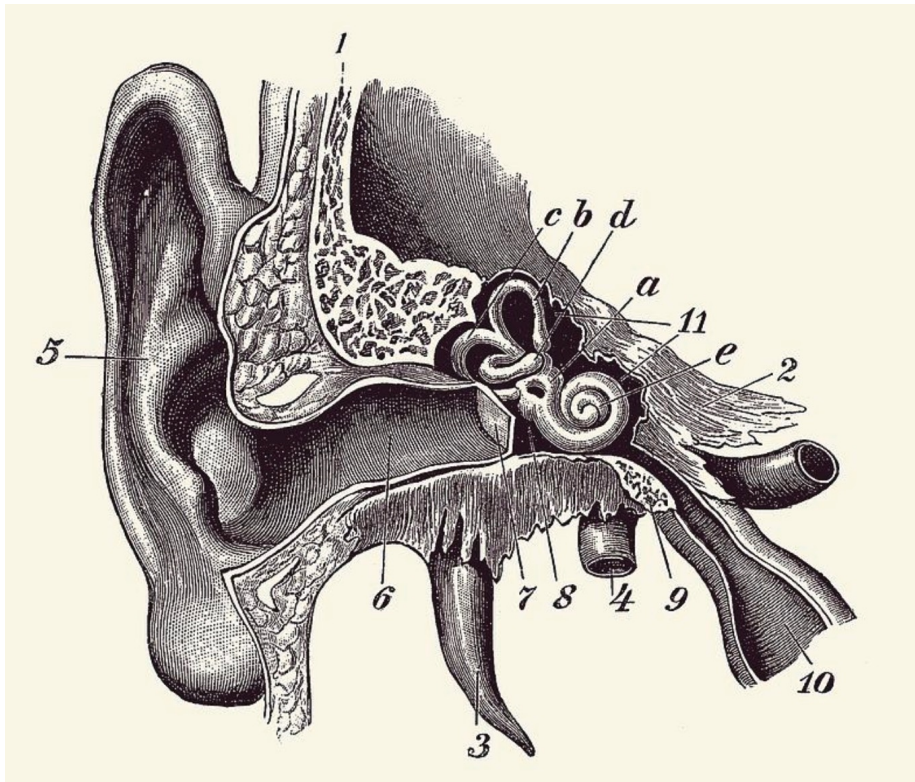


Exemples d'otite moyenne aiguë



**Exemples d'OMC suppurée (haut)
et de cholestéatome (bas)**





Menière :

- **Définition :** Maladie causée par une anomalie de résorption de l'endolymphe dans l'oreille interne. La cause précise est indéterminée et la maladie débute en général chez les adultes entre 40 et 50 ans.
- **Cliniques:** Épisode durant **20 minutes à 12h** de **surdité de perception, acouphène** et **vertige** périphérique (triade de Menière). Des nystagmus et la sensation d'engorgement de l'oreille peuvent être présents.
- **Diagnostique:** Clinique (épisodes récidivants et compatible dans la durée), démonstration à l'**audiométrie** d'une surdité de perception prédominant dans les fréquences basses et moyenne (grave). En cas de suspicion d'origine centrale, une imagerie en coupe devrait être effectuée.
- **Critères :** **2 épisodes ou plus** de vertige durant 20' à 12h + surdité de perception prédominant dans les fréquences basses à l'audiométrie + autres symptômes du côté atteinte (acouphène, oreille « pleine »...)
- **Traitement :** Lors des crises, administrer des médicaments avec effets supprimeurs sur l'oreille interne => **Antiémétique, BZD, anti-histaminique de 1^{ère} génération**
En dehors des crises : diète pauvre en sodium (< 3g par jour), réduction du stress, éviction des triggers si identifiés (alcool, café, nicotine...). Si nécessaire introduction d'un traitement pharmacologique au long court : **Diurétique thiazidique** ou **acétalozamide, betahistine**. En dernier recours, administration localement et à haute doses de médicaments toxiques pour l'oreille interne : **Gentamycine** ou administration locale de stéroïdes. Autrement, résection chirurgicale : **neurectomie vestibulaire** ou **labyrinthectomie**

Neuronite vestibulaire :

- **Définition :** Inflammation idiopathique du nerf vestibulaire, souvent para-infectieuse après une IVRS. Après le VPPB, il s'agit de la seconde cause la plus fréquente de vertige et touche les adultes entre 30 et 50 ans.
- **Cliniques:** Apparition rapide de symptômes liés à un déficit unilatérale du NC.VIII (versant cochléaire en général épargné) avec un nystagmus du côté sain, des vertiges et une chute du côté touché
- **Diagnostique:** Diagnostic clinique (effectuer la **Head-impulse test** : green flag)
- **Traitement :** Le traitement le plus important est la **réhabilitation** vestibulaire précoce. En aiguë, des médicaments avec effets supprimeurs sur la fonction vestibulaire peuvent-être prescrit. En revanche, il n'y a plus d'indication pour une utilisation systématique de **stéroïdes**. L'évolution est normalement spontanément favorable avec une cessation des vertiges après quelques jours et une résolution complète en 2-3 semaines. Dans les cas réfractaires, possibilités d'effectuer une **neurectomie vestibulaire** ou **labyrinthectomie**

VPBB:

- **Définition :** Vertige paroxystique provoqué par des rotations brusques de la nuque, en relation avec des calculs dans les canaux semi-circulaire. Cause la plus fréquente de vertige, pic d'incidence entre 50-60 ans !
- **Cliniques:** Épisode brutaux et court (< 1 minute) de vertige avec nystagmus unidirectionnel. Comme pour la neuronite vestibulaire, il n'y en général pas de signe cochléaire associées (acouphène, surdité de perception...)
- **Diagnostique:** Déclenchement des symptômes (vertiges et nystagmus) lors de la **manœuvre de Dix-Hallpike**
- **Traitement :** Manœuvre de repositionnement des calculs (manœuvre de Epley), en général évolution spontanément favorable y-compris sans manœuvre de repositionnement après quelques semaines.